

AGRADECIMIENTOS

Ante todo, elevamos nuestra más profunda gratitud a Dios por otorgarnos la serenidad, la salud, la sabiduría y el coraje necesarios para transitar los momentos de mayor exigencia a lo largo de nuestra formación académica, siendo la luz constante que orientó cada uno de nuestros pasos hasta culminar con éxito este importante objetivo.

A nuestras familias y a nuestros padres, por constituir el pilar fundamental sobre el cual se erige este logro compartido. Gracias por cada sacrificio en silencio, por su entrega incondicional, su paciencia y la fe constante que depositaron en nosotras en los instantes de duda. Este triunfo representa el fruto directo de su esfuerzo y el reflejo vivo de los valores que nos han inculcado día a día.

Expresamos nuestro más sincero reconocimiento al Instituto Universitario de Tecnología "Elías Calixto Pompa" (IUTECP) y a su dedicado cuerpo docente, por brindarnos las herramientas técnicas y éticas que cimentaron las bases de nuestra especialidad. De igual manera, manifestamos nuestro respeto y agradecimiento al personal médico, de enfermería y administrativo del Hospital "Dr. Felipe Guevara Rojas" de El Tigre, en especial al equipo del área de Sala de Partos, por abrirnos las puertas de la institución y brindarnos el apoyo necesario para el desarrollo de esta investigación.

A las jóvenes y pacientes que colaboraron de manera sincera en este estudio, pues su disposición fue clave para dar sentido y sustento a nuestra propuesta de consejería. Asimismo, nuestro agradecimiento a los amigos y a todas aquellas personas que, con una palabra de aliento, un consejo oportuno o un gesto solidario, aportaron su grano de arena para convertir esta meta en una realidad.

DEDICATORIA

Dedicamos con profunda fe y gratitud este logro en primer lugar a Dios, por otorgarnos la vida, la salud y la sabiduría necesarias para transitar cada etapa de nuestra formación con templanza, siendo el guía constante que iluminó nuestro camino y nos dio la fortaleza para superar las dificultades hasta alcanzar esta valiosa meta.

A nuestros padres y familias, pilares inquebrantables de nuestras vidas. Este trabajo es el reflejo de sus sacrificios en silencio, de su amor incondicional y de la confianza ciega que depositaron en nosotras en todo momento. Cada hora de estudio y cada obstáculo superado en esta travesía llevan la huella de su esfuerzo, por lo que este triunfo les pertenece tanto como a nosotras.

A nuestro equipo de trabajo y compañeros de estudio, por la unión, la perseverancia y el respeto mutuo que mantuvimos a lo largo de este trayecto. Gracias por cada jornada de esfuerzo compartido, por las noches de desvelo, por la empatía en los momentos de mayor exigencia y por demostrar que con trabajo en equipo los retos se transforman en grandes aprendizajes.

Finalmente, a cada persona que nos brindó una palabra de motivación, un consejo oportuno o una muestra de apoyo sincero durante este proceso. Su respaldo y fe en nosotras fueron un impulso invaluable para mantener firme nuestro compromiso profesional y hacer realidad este sueño.

INTRODUCCIÓN

La adolescencia es, por definición, la etapa de las transiciones, el descubrimiento y la construcción del futuro. Sin embargo, cuando una prueba de embarazo da positivo a los quince años, el reloj del desarrollo biológico, emocional y académico sufre una alteración abrupta. El embarazo adolescente no representa únicamente un fenómeno demográfico o un indicador en los informes de salud pública; constituye una bifurcación radical en el proyecto de vida de miles de jóvenes. Este fenómeno expone de inmediato las profundas grietas de la desigualdad social, la deserción escolar y la falta de acceso a una educación sexual integral.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la gestación en mujeres de 10 a 19 años es uno de los desafíos sociales y de salud pública más complejos de la actualidad, el cual se encuentra ligado directamente a la vulnerabilidad socioeconómica y a una relación de doble vía con la pobreza: la falta de oportunidades incrementa el riesgo de un embarazo no planificado, y este a su vez detona la deserción escolar, limitando el futuro

laboral y perpetuando el ciclo de exclusión. A escala global e internacional, la Organización de las Naciones Unidas promueve a través del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS 3) la garantía del acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva. Alineado con este propósito, la UNESCO postula la obligatoriedad de implementar programas de Educación Integral en Sexualidad (EIS) respaldados por evidencia científica.

Al examinar el panorama comparativo internacional, se evidencian realidades contrastantes. En países desarrollados como Canadá, a pesar de contar con un robusto sistema de bienestar social, directrices nacionales sobre educación sexual y clínicas juveniles especializadas (como en Ontario o Columbia Británica), persisten barreras críticas de exclusión en comunidades rurales y reservas indígenas donde las tasas de fecundidad juvenil pueden duplicar o triplicar el promedio nacional debido a la geografía y a la escasez de médicos. Por otro lado, en América del Sur, la República de Chile ha logrado consolidar una de las tasas más bajas de la región mediante normativas de protección integral y la implementación de "Espacios Amigables" en la Atención Primaria de Salud (APS), aunque enfrenta desafíos operativos locales vinculados a recortes presupuestarios y brechas en la aplicación uniforme de la educación sexual en los liceos.

Esta problemática adquiere dimensiones críticas en la República Bolivariana de Venezuela. Pese a contar con un sólido marco jurídico protector —fundamentado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999), la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNA, 2015) y directrices como el Plan ENAPTA—, el país registra una de las tasas de embarazo adolescente más altas de Sudamérica, estimándose entre 95 y 101 nacimientos por cada 1,000 jóvenes de 15 a 19 años. Informes de organizaciones como AVESA (2023) y el UNFPA (2022) revelan que la realidad cotidiana dista de la normativa legal: existe una marcada escasez de anticonceptivos modernos y de larga duración (LARC) en la red pública, deficiencias operativas en las consultas diferenciadas para adolescentes y una precaria implementación institucional de la educación sexual en las instituciones educativas, lo que propicia que hasta un porcentaje alarmante de jóvenes abandonen sus estudios de manera definitiva.

Esta compleja realidad se manifiesta de forma directa e inmediata en el ámbito local de la ciudad de El Tigre, estado Anzoátegui, específicamente en el área de Sala de Partos del Hospital General "Dr. Felipe Guevara Rojas". En este centro asistencial es evidente el flujo constante de gestantes y puérperas de entre 12 y 19 años, muchas de ellas con un deficiente o nulo control prenatal, lo que incrementa los riesgos biológicos materno-infantiles y colapsa la capacidad operativa del servicio de gineco-obstetricia. En la localidad convergen múltiples

factores: la ausencia de consultas diferenciadas que funcionen de manera continua y confidencial, las barreras socioeconómicas para adquirir anticonceptivos en el mercado privado, las fallas en el suministro institucional y el retraso en la aplicación efectiva de la Educación Integral en Sexualidad en los planteles del municipio Simón Rodríguez.

Desde la perspectiva psicosocial de Erik Erikson, la adolescencia es la fase primordial para la construcción de la identidad y el proyecto de vida; asumir una maternidad temprana interrumpe drásticamente este proceso, forzando la deserción escolar, limitando la inserción en el campo laboral formal y precarizando la economía de los hogares a largo plazo. Por consiguiente, la presente investigación no busca señalar ni juzgar la maternidad adolescente. Su propósito fundamental es diseñar una estrategia de consejería de enfermería en planificación familiar al momento del alta médica en el área de Sala de Partos del Hospital "Dr. Felipe Guevara Rojas" de El Tigre, orientada a superar las barreras de acceso identificadas, caracterizar el perfil sociodemográfico y obstétrico, evaluar el nivel de conocimiento sobre anticonceptivos modernos y prevenir de forma asertiva el embarazo adolescente subsecuente.

CAPÍTULO I EL PROBLEMA

Planteamiento del Problema

El embarazo adolescente - definido por la Organización Mundial de la Salud como la gestación en mujeres de 10 a 19 años - es uno de los desafíos sociales y de salud pública más complejos de la actualidad. Lejos de ser un evento puramente biológico, la teoría social lo reconoce como un problema estructural ligado directamente a la vulnerabilidad socioeconómica. Existe una relación de doble vía entre la maternidad temprana y la pobreza: La falta de oportunidades aumenta el riesgo de un embarazo no planificado, y este, a su vez, detona la deserción escolar, limitando el futuro laboral de las jóvenes y repitiendo el ciclo de exclusión.

En el ámbito internacional, el bienestar integral y el respeto a los derechos humanos de la población joven son pilares fundamentales para el avance y la equidad social. La Organización de las Naciones Unidas, a través del Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 promueve de manera explicativa que los gobiernos deben garantizar el acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva, integrando la planificación familiar en sus estrategias públicas nacionales.

Alineado con este propósito, la UNESCO postula la obligatoriedad de implementar programas de Educación Integral en Sexualidad respaldados por evidencia científica.

A nivel de América del Norte, los marcos políticos se caracterizan por una fuerte inversión en Salud Comunitaria y un enfoque de derechos individuales y diversidad social. La oficina regional de la Organización Mundial de la Salud para América del Norte promueve directrices que exigen a los países industrializados coordinar estrechamente los ministerios de Salud, desarrollo social y educación para erradicar las brechas de vulnerabilidad.

Bajo estas recomendaciones regionales, el sistema de salud pública debe asegurar la cobertura total y gratuita en la provisión de anticonceptivos modernos y de larga duración para la población menor de edad. El propósito regional es empoderar a la juventud para que tome decisiones reproductivas conscientes e informadas, garantizando que el inicio de su vida sexual no se traduzca en embarazos no planificados que afecten su inserción económica y profesional.

Precisamente bajo este enfoque, en Canadá, el marco institucional que protege a la infancia y a la juventud se basa en la descentralización de competencias y en la justicia social. Aunque la salud y la educación dependen de cada provincia, el marco nacional se rige por la carta canadiense de derechos y libertades y la ley de salud en Canadá, las cuales establecen que el acceso de atención médica debe ser universal, equitativa y libre de barreras económicas. Asimismo la agencia de la salud pública de Canadá emite las directrices canadienses sobre educación en salud sexual, un estándar nacional que obliga a las escuelas enseñar sobre consentimiento, uso de anticonceptivos y proyecto de vida.

En la práctica, provincias como Ontario y Columbia Británica ofrecen anticonceptivos gratuitos para menores de 25 años y habilitan clínicas especializadas en salud juvenil, las cuales brindan espacios gratuitos, confidenciales y accesibles. En paralelo, los ministerios de educación provinciales exigen un currículo obligatorio de salud sexual integral, asegurando que los adolescentes cursen su educación informados y con acceso a prevención, evitando un embarazo temprano.

[...] hacia el contexto latinoamericano, Chile refleja una dinámica comparable, aunque son evidentes las diferencias en el avance de las políticas públicas y las leyes a través de los años, la realidad del país muestra desafíos y desigualdades importantes en su aplicación diaria. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Chile ha logrado consolidar la tasa de embarazo adolescente más baja de la región. El país pasó de registrar 56 nacimientos por cada 1000 jóvenes en el año 2008 a cerca de 23 por cada 1000 en las mediciones recientes. A pesar de este descenso sobresaliente, miles de jóvenes de entre 15 y 19 años siguen enfrentando una maternidad no planificada cada año. El síntoma principal de este problema ya no es el desabastecimiento general, sino la profunda brecha de desigualdad socioeconómica y geográfica que afecta a los sectores más vulnerables.

De acuerdo con estudios de la corporación World Vision Chile (2024), la probabilidad de que una adolescente quede embarazada sigue concentrándose de manera desproporcionada en las comunas de menores ingresos y en las zonas rurales del país. En el plano de la salud, aunque los "Espacios amigables" han sido claves para masificar el uso de anticonceptivos modernos y de larga duración, estos servicios enfrentan serios problemas de continuidad operativa en los Centros de Salud Familiar (CESFAM) comunales. Las alertas y protestas de gremios de la salud en plataformas como Instagram 2026 evidencian que el recorte de

presupuestos municipales ha provocado cierres temporales o reducciones críticas en los equipos multidisciplinarios (matronas, psicólogos y trabajadores sociales). Esto limita los horarios de atención y debilita la privacidad y confidencialidad que las leyes prometen a los jóvenes en los sectores vulnerables.

Por otra parte, el sistema escolar chileno arrastra una deuda histórica respecto a la promoción educativa. Investigaciones del Centro de Estudios Públicos y la Universidad Católica de Chile revelan que la falta de un diseño unificado y obligatorio de Educación Integral en Sexualidad (EIS) deja la formación de estudiantes a criterio de cada colegio.

Como consecuencia, muchos liceos abordan el tema con un enfoque exclusivamente preventivo del embarazo o de infecciones de transmisión sexual (ITS) las cuales han aumentado drásticamente en la población juvenil, dejando de lado el apoyo psicológico y el proyecto de vida. El impacto social de estas carencias sigue siendo determinante: cerca del 8,4% de las adolescentes chilenas que enfrentan una gestación terminan abandonando o interrumpiendo su trayectoria educativa formal. Esto frena su inserción en la educación superior y perpetúa las brechas de vulnerabilidad económica. Por lo tanto, el embarazo a temprana edad en Chile no debe analizarse como un indicador superado por las estadísticas generales, sino como una problemática de equidad social y acceso oportuno que afecta el desarrollo de las jóvenes en contextos específicos y que exige proteger la estabilidad de los programas locales de salud comunitaria.

Así mismo, en la República Bolivariana de Venezuela, el marco normativo, institucional y operativo respecto a la salud sexual y reproductiva de la juventud se encuentra rigurosamente fundamentado en el ordenamiento constitucional y legal vigente. Desde una perspectiva jurídica superior, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999) en su artículo 76 instituye que el Estado tiene la obligación de garantizar una asistencia y protección integral a la maternidad en general, asegurándose que los procesos de gestación y crianza se desarrollen en condiciones óptimas de bienestar físico, mental y socioeconómico. De manera vinculante, el artículo 78 de la carta Magna establece la prioridad absoluta de los niños, niñas y adolescentes, obligando al Estado, las familias y la sociedad a asegurar su desarrollo pleno y armónico.

Para operativizar estos preceptos constitucionales, la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA, 2015) define con exactitud las competencias del entorno social. En su artículo 50, consagra el derecho fundamental de todos los menores de edad a ser informados e informadas en materia de salud sexual y reproductiva, estipulando que dicha información debe ser veraz, oportuna, científica y adaptada a su etapa de desarrollo. Asimismo, el artículo 43 de la referida Ley obliga al Estado a garantizar el acceso a servicios de la salud gratuitos y de alta calidad, dirigidos específicamente a la prevención de enfermedades y a la orientación familiar.

Bajo este amparo legal, el marco metodológico y programático del país se halla estructurado en el Plan Nacional de Prevención del Embarazo a Temprana Edad y en la Adolescencia (Plan ENAPTA), el cual exige una articulación intersectorial sin fisura entre el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE).

De acuerdo con Tovar y col, (2017), el diseño de políticas públicas en el contexto venezolano establece de forma vinculante que las instituciones de educación media y

diversificada ejecuten de manera obligatoria y transversal proyectos pedagógicos de aula enfocados en el proyecto de vida, la toma de decisiones asertivas y el autocuidado, evitando el abordaje de la sexualidad como un tema tabú o meramente biológico.

En el plano operativo local y comunitario, la Red de Atención Comunal de Salud (RACS), conformada por los Consultorios Médicos Populares (CMP) y los Centros de Diagnóstico Integral (CDI), cada centro de salud municipal tiene la obligación de contar con consultas diferenciadas para adolescentes. Estas se definen como clínicas amigables, confidenciales y libres de estigma, atendidas por personal multidisciplinario (médicos, psicólogos y trabajadores sociales) capacitado rigurosamente para romper las barreras de acceso al sistema de salud.

Asimismo, el sistema público de salud tiene la obligación de mantener un abastecimiento continuo, gratuito y con 100% de cobertura de métodos anticonceptivos modernos, priorizando los anticonceptivos reversibles de larga duración (LARC, por sus siglas en inglés), como los implantes subdérmicos y los dispositivos intrauterinos (DIU), debido a su alta tasa de efectividad en la población joven (UNFPA Venezuela, 2022). Finalmente, la contraloría y el apoyo social en el sector comunitario deben ser ejercidos de forma articulada por los consejos de protección de Niños, Niñas y Adolescente (CPNNA) y los comités de salud de los consejos comunales. Estos entes locales deben asegurar el monitoreo activo de los factores de riesgo en el sector geográfico, garantizando que ninguna adolescente interrumpa su escolaridad debido a una gestación y protegiendo de forma irrestricta sus derechos humanos fundamentales.

Sin embargo, aunque Canadá cuenta con recursos económicos avanzados y un robusto sistema de bienestar social, la realidad nacional demuestra que persisten profundas desigualdades y barreras críticas según el origen y la ubicación de las jóvenes. Datos estadísticos del Instituto Canadiense de Información Sobre la Salud reflejan que la tasa de fecundidad adolescente general se mantiene a niveles bajos, promediando cerca de 8 nacimientos por cada 1.000 jóvenes de entre 15 y 19 años. A pesar de este panorama favorable en las grandes urbes, el fenómeno del embarazo no planificado sigue siendo un problema de exclusión latente. El síntoma principal de esta realidad no es la falta de presupuesto gubernamental, sino la marcada brecha de inequidad que afecta a las comunidades rurales y a las poblaciones originarias o indígenas del país.

De acuerdo con las investigaciones de la Sociedad de Obstetras y Ginecólogos de Canadá, en las reservas de las Primeras Naciones y en los territorios aislados del norte, las tasas de embarazo juvenil llegan a ser hasta cinco veces más elevadas que el promedio nacional. En el plano de la salud, a pesar de la existencia de las clínicas especializadas en Salud Juvenil, la geografía se convierte en una barrera severa. En las zonas aisladas, la escasez crónica de médicos de cabecera y el alto costo de transporte para viajar a los centros hospitalarios urbanos limitan el acceso real de las adolescentes a los implantes subdérmicos o dispositivos intrauterinos de larga duración. Además, en los pueblos pequeños de las provincias rurales, el miedo a la falta de confidencialidad y el juicio social empujan a los jóvenes a ocultar su estado, retrasando los controles prenatales indispensables.

En el sector educativo, la aplicación de las Directrices Canadienses sobre educación en salud sexual sufre de una fuerte fragmentación práctica, como la educación depende de

cada provincia, muchos distritos escolares de corte conservador o ubicados en entornos rurales omiten o reducen los programas obligatorios de educación sexual, limitándolos a enfoques biológicos y evadiendo temas esenciales como el proyecto de vida y los derechos reproductivos. El impacto de estas carencias institucionales sigue vulnerando el futuro de las jóvenes de sectores desfavorecidos; estadísticas del Ministerio de Desarrollo Social Canadiense señalan que las adolescentes que afrontan una maternidad temprana en contextos de exclusión tienen una probabilidad considerablemente menor de completar la educación superior técnica o universitaria.

Esto perpetúa ciclos de dependencia económica de las ayudas estatales y frena su autonomía laboral en el mercado contemporáneo.

Por lo tanto, el embarazo a temprana edad en Canadá se define hoy en día como un problema de justicia social, distribución geográfica y equidad cultural que demuestra que contar con un alto desarrollo económico no basta si los servicios de salud y educación comunitarios no se adaptan de forma justa a las poblaciones más aisladas y vulnerables.

Una realidad distinta se observa en América del sur; específicamente en la República de Chile, la protección de la infancia y la adolescencia se rige por un marco institucional y legal que busca la equidad en el acceso a la salud. Desde el año 2022, con la promulgación de la Ley N° 21.430 sobre Garantías y Protección integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, el Estado chileno asume la obligación de asegurar el desarrollo físico, mental y social de los menores de edad. Asimismo, la Ley N° 20.418 fija las normas sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad, estableciendo que toda persona (incluyendo a los adolescentes) tiene derecho a recibir educación y servicios de salud sexual sin discriminación. Dentro de este marco operativo ideal, el Ministerio de Salud (MINSAL), a través de sus orientaciones técnicas, estipula que la Red de Atención Primaria de Salud (APS) compuesta por los centros de Salud Familiar (CESFAM) debe contar con los denominados Espacios Amigables para Adolescentes. El diseño de estos programas exige que se atienda a los jóvenes en horarios diferenciados, resguardando estrictamente la confidencialidad y ofreciendo una entrega constante y gratuita de métodos anticonceptivos regulados por el Estado. A la par, el Ministerio de Educación (MINEDU) tiene la tarea de promover lineamientos escolares que fomenten la afectividad y la prevención desde un enfoque de derechos. De este modo, las adolescentes chilenas deberían transitar su educación básica y media contando con un sistema de salud comunitaria cercano y un entorno escolar que las apoye para evitar la deserción, asegurando que su desarrollo educativo no se vea interrumpido por una gestación no planificada.

No obstante, aunque a lo largo de los años se han creado leyes y planes para proteger a la juventud, la realidad actual del país es muy diferente. Datos del fondo de población de las Naciones Unidas (UNPA Venezuela 2022) muestran que Venezuela tiene una de las tasas de embarazo adolescente más alta de Sudamérica, calculando que ocurren entre 95 y 101 nacimientos por cada 1000 jóvenes entre 15 y 19 años. Esto demuestra que las leyes escritas no se están aplicando con éxito en el día a día de las comunidades. El reflejo más evidente de este problema es el abandono de los centros de salud locales y la falta constante de métodos anticonceptivos gratuitos. De acuerdo con informes de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (AVESA, 2023), muy pocos jóvenes

logran conseguir anticonceptivos modernos en los hospitales o ambulatorios públicos. Los métodos de larga duración, como los implantes en el brazo o los dispositivos intrauterinos (DIU), casi nunca están disponibles en las comunidades debido a fallas en la distribución del Estado. Esto obliga a las adolescentes a comprarlos en farmacias privadas a precios muy altos que sus familias no pueden pagar. Además, las "Consultas Diferenciadas para Adolescente", que según el Ministerio de la Salud (MPPS 2021) deberían ser espacios amigables, privados y con psicólogos o médicos especializados, no están funcionando en la mayoría de los ambulatorios del país por falta de personal entrenado.

En el ámbito educativo, la situación tampoco es favorable, como explican Terán y Col (2017), la falta de presupuesto, la escasez de profesores y la ausencia de guías escolares actualizadas hacen que la educación sexual en los liceos sea casi inexistente o se limite a temas puramente biológicos, dejando de lado la orientación de vida.

Las consecuencias de este descuido son graves, registros de organizaciones como Niña Madre 2025 señalan que 7 de cada 10 adolescentes que quedan embarazada abandonan sus estudios definitivamente. Dejar el liceo a temprana edad les impide conseguir un buen empleo en el futuro, afecta sus ingresos económicos y mantiene a sus familias en una situación de pobreza que se repite de generación en generación. Por lo tanto, el embarazo a temprana edad en Venezuela ya no se puede ver como un hecho aislado o una simple emergencia médica, sino como un problema social y de salud pública, grave que frena el desarrollo de las jóvenes y requiere atención urgente en las comunidades.

Para abordar de manera profunda y estructurada, el embarazo a temprana edad constituye una realidad crítica que se observa de forma directa e inmediata en la ciudad de El Tigre, estado Anzoátegui, específicamente en el Hospital "Dr. Felipe Guevara Rojas". En este centro hospitalario, el problema es directamente visible en el flujo constante de entre 12 y 19 años que ingresan al servicio de sala de parto para recibir atención obstétrica. Como señala la Organización Mundial de la Salud (OMS), la gestación en esta etapa conlleva altos riesgos biológicos; en el caso local, la mayoría de estas jóvenes acuden con un deficiente o nulo control prenatal, lo que genera complicaciones médicas frecuentes y termina colapsando la capacidad operativa del área de Gineco-Obstetricia en el hospital. Al analizar el origen de esta problemática en el contexto de El Tigre, se observan fallas directas tanto en la atención médica, como en el ámbito educativo del municipio Simón Rodríguez, en el centro de salud las consultas diferenciadas para adolescentes dentro de el Hospital Dr. Felipe Guevara Rojas no están funcionando de manera continua por la falta de personal especializado y de espacios clínicos confidenciales. A esto se le suma la dificultad que tienen las jóvenes para acceder a métodos anticonceptivos en la red pública local, en el ámbito escolar en los liceos de la zona existe un [bajo] retraso en Educación Integral en Sexualidad (EIS). Esto contraviene lo establecido en el artículo 50 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y del Adolescente (LOPNNA), el cual garantiza el derecho de la juventud a recibir información sobre salud reproductiva, dejando a las estudiantes de la localidad sin herramientas conceptuales para el autocuidado. De no intervenir esta situación en el municipio, el pronóstico para las jóvenes de la localidad es preocupante, en la salud aumentarán las complicaciones médicas de la madre y del recién nacido en el Hospital Dr. Felipe Guevara Rojas, debido a los peligros de afrontar un parto cuando el

organismo no ha completado su desarrollo. En lo social y educativo la consecuencia más directa en El Tigre será el incremento del abandono escolar, desde la perspectiva de Erik Erikson, la adolescencia es la etapa en la que se construye la identidad y proyecto de vida, asumir la maternidad a temprana edad interrumpe altamente este proceso, obligando a las jóvenes a abandonar las aulas de clases. Esto las excluye del campo laboral formal y precariza la economía de sus hogares a largo plazo, para mitigar esta problemática en la ciudad de El Tigre se requiere formular acciones locales concretas, en primer lugar, es necesaria la reactivación hospitalaria mediante el reestructuramiento del área de consulta y orientación para adolescentes dentro del Hospital Felipe Guevara Rojas, garantizando una atención médica y psicológica libre de estigmas. Asimismo, se deben articular esfuerzos entre los centros de salud locales para asegurar el suministro regular de métodos anticonceptivos en los ambulatorios de las distintas comunidades de la zona, por último, como parte fundamental, integrar las orientaciones de la UNESCO sobre la Educación Integral de la Sexualidad a través de programas de orientación pedagógica en los liceos del Municipio Simón Rodríguez. De esta manera se brinda a los jóvenes información clara y oportuna que les permite tomar decisiones conscientes y planificar su futuro.

La justificación de este tema se fundamenta en la necesidad de abordar el aumento de embarazos a temprana edad en la ciudad de El Tigre, Municipio Simón Rodríguez. Esta situación afecta la salud, el bienestar y los estudios de las adolescentes de entre 12 y 19 años, e impacta negativamente a sus familias. Además, genera una gran saturación en el Hospital General "Dr. Felipe Guevara Rojas", ya que al área de sala de parto llegan continuamente jóvenes con complicaciones o sin sus controles médicos al día. Por eso, este trabajo busca ayudar a prevenir estos riesgos y evitar que las jóvenes abandonen el liceo. Desde el punto de vista académico y del área de la salud, este trabajo es importante porque nos permite examinar de cerca las causas reales del embarazo precoz en nuestra zona. Contribuye a la práctica al mostrar las fallas que hay actualmente en la prevención, como la falta de funcionamiento constante de las consultas para adolescentes en el Hospital y la falta de educación sexual en los liceos, sirviendo como un punto de referencia actualizado para entender lo que pasa en el Sur Anzoátegui. En cuanto a la originalidad, aunque el embarazo en adolescentes es un tema muy conocido, lo que hace diferente a este estudio es que mezcla las distintas realidades de Canadá, Chile y Venezuela, específicamente en la ciudad de El Tigre. Y además de hablar de forma general sobre Venezuela, se centra directamente en lo que ocurre dentro del Hospital Dr. Felipe Guevara Rojas y en las escuelas del municipio, dando una visión propia y real de nuestra comunidad. En la parte práctica o aplicabilidad, los resultados de esta investigación se pueden usar para orientar a las autoridades de salud y educativas de El Tigre. Sirve como una guía para organizar charlas de prevención, promover que se reactiven las consultas especiales para adolescentes en el Hospital y crear estrategias educativas más claras en los liceos, logrando que la información realmente les llegue a los jóvenes!

Objetivo General

Diseñar una estrategia de consejería de enfermería en planificación familiar al momento del alta médica en el área de Sala de Partos del Hospital Dr. Felipe Guevara Rojas de El Tigre, orientada a superar las barreras de acceso identificadas y prevenir el embarazo adolescente subsecuente.

Objetivos Específicos

Caracterizar el perfil sociodemográfico y obstétrico (edad, procedencia, nivel educativo, situación económica y paridad) de las adolescentes gestantes y puérperas ingresadas en el Hospital de El Tigre, Dr. Felipe Guevara Rojas.

Identificar el nivel de conocimiento que poseen las adolescentes que asisten al Hospital Felipe Guevara Rojas sobre el mecanismo de acción, uso correcto y efectividad de los métodos anticonceptivos modernos.

Determinar las barreras socioeconómicas e institucionales (costos en el mercado, escasez de insumos en el Hospital Felipe Guevara Rojas y transporte) que limitan el acceso de las adolescentes a los anticonceptivos.

Proponer un catálogo de alternativas de intervención y contenidos educativos clave en planificación familiar, derivados de las barreras de acceso y el nivel de conocimiento identificados en las adolescentes.

Capítulo II Marco Teórico

Según Hernández et al (2007) el marco teórico "es un compendio escrito de artículos, libros y otros documentos que describen el Estado pasado y actual del conocimiento sobre el problema de estudio, ayuda a documentar cómo nuestra investigación agrega valor a la literatura existente." En el presente trabajo el marco teórico está compuesto por los antecedentes, las Bases Teóricas y la definición de Términos Básicos.

Aguilar y Ramírez (2018) en su trabajo de grado titulado factores que inciden en el aumento del embarazo en adolescente de 12 a 17 años en el Hospital Cruz Roja en el período de tiempo Febrero-Julio 2018, para obtener el título de Licenciado en enfermería en el instituto de ciencias y estudio superiores de Tamaulipas, plantea como objetivo general determinar los principales factores que inciden en el aumento del embarazo en adolescente de 12 a 17 años en el Hospital Cruz Roja Mexicana delegación Puebla en el período de tiempo Febrero-Julio 2018.

Este estudio es un tipo descriptivo, observacional, no experimental, que mide a la vez la prevalencia de la exposición del grupo de edad en estudio y el efecto en una muestra poblacional en un solo momento temporal, es decir, permite estimar la magnitud, la distribución y la proporción de una población que presentan un mismo patrón determinado y los factores que puedan influir para que esta se presente.

El estudio presente llegó a la conclusión de que el 46% de las pacientes adolescentes se concentró en el rango de 11 a 13 años. En cuanto al nivel educativo, el 56% de la población de estudio concluyó únicamente la primaria y el 44% finalizó la secundaria.

Finalmente, pertenecer al rango de edad de 11 a 13 años constituye un factor de riesgo estadísticamente significativo para el embarazo subsecuente para el embarazo subsecuente en la adolescencia. Asimismo, una menor escolaridad y la falta de información adecuada (tanto por parte de los padres como de campañas publicitarias) elevan el riesgo de gestación a temprana edad. Además, la ausencia de métodos de planificación familiar, tanto antes como después del primer embarazo, actúa como un factor de riesgo para un segundo embarazo o para la adquisición de infecciones de transmisión sexual, tales como sífilis, gonorrea o VIH.

Se relaciona con la presente investigación, debido a que su objetivo general se enfoca en identificar los factores que inciden en el aumento de embarazo en adolescente, punto que destaca mucho en el cual casi todos nuestro objetivos tratan sobre en nuestro trabajo identificar estas barreras socioeconómicas e institucionales, y la falta de conocimiento de estas adolescentes sobre mecanismo de acción y el uso correcto de anticonceptivos.

Este estudio nos aporta información que nos sirve para planificar medidas preventivas, evitar un segundo embarazo no deseado, reducir la morbilidad mediante el espaciamiento de los embarazos, y ofrecer una mejor atención a futuros casos, lo que nos lleva a nuestro gran objetivo que es diseñar una estrategia de conservación de enfermería en planificación familiar al momento del alta médica en el Área de Sala de partos del Hospital "Dr. Felipe Guevara Rojas" de El Tigre, orientada a superar las barreras de acceso identificadas y prevenir el embarazo en adolescente subsecuente.

Bases Teóricas

Embarazo en adolescentes

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2024) [El embarazo en la adolescencia es un fenómeno mundial con causas claramente conocidas y graves consecuencias para la salud, la sociedad y la economía. A escala mundial, la tasa de natalidad en adolescentes ha disminuido, pero las tasas de cambio han sido desiguales entre las regiones. También hay enormes variaciones en los niveles entre los países y dentro de ellos. El embarazo en la adolescencia tiende a ser mayor en personas con menos educación o de bajo estatus económico. Además, el progreso en la reducción de los primeros nacimientos de madres adolescentes es más lento en estos y otros grupos vulnerables, lo que conduce a una creciente desigualdad. El matrimonio infantil y el abuso sexual de niñas ponen a estas últimas en mayor riesgo de embarazo, a menudo no deseado.

En muchos lugares, los obstáculos para obtener y usar anticonceptivos impiden que las adolescentes eviten embarazos no deseados. Cada vez se presta más atención a mejorar el acceso de las adolescentes embarazadas y con hijos a una atención materna de calidad. La OMS colabora con asociados para promover la atención prestada al embarazo en la adolescencia, crear una base empírica para la acción, elaborar instrumentos de apoyo a las políticas y los programas, crear capacidad y apoyar a los países para que aborden eficazmente el embarazo en la adolescencia]. (parr 1)

La relación que tiene este texto con nuestro trabajo, es que nos sirve para demostrar que nuestra investigación es importante y está bien fundamentada. Nos ayuda a explicar que el embarazo adolescente no es solo un problema al azar, sino una realidad grave respaldada por expertos mundiales. Al usar estos datos, podemos justificar exactamente a quienes debemos ayudar, cuales son las causas reales que debemos atacar, y lo más importante, nos da la base para proponer soluciones prácticas que se puedan aplicar de inmediato para cambiar esta situación y brindar el apoyo que necesitan estas adolescentes.

Términos Básicos

Embarazo: se define como los nueve meses durante los cuales el feto se desarrolla en el útero de la mujer. Es una etapa que marca la vida de una mujer pasando por diversos cambios fisiológicos y psicológicos. Existe un crecimiento del útero, aumento de los pechos y del volumen sanguíneo, que puede provocar anemia fisiológica del embarazo. (OMS, 2020).

Adolescencia: es la fase de la vida que va de la niñez a la edad adulta, osea desde los 10 hasta los 19 años. Representa una etapa singular del desarrollo humano y un momento importante para sentar las bases de la buena salud (OMS, s.f).

Fecundidad: se define como la realización efectiva de la reproducción biológica y un componente clave de la salud reproductiva que abarca la capacidad de concebir y llevar un embarazo a término. (OMS, s.f).

Sexualidad: es un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. Abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual (OMS, 2006).

Anticonceptivos: se definen como las estrategias para impedir o reducir de forma significativa las probabilidades de que se produzca la fecundación y, con ello, el embarazo, al mantener relaciones sexuales con penetración vaginal. (Reproducción asistida ORG, 2023).

Métodos barrera: se trata de anticonceptivos que evitan la llegada de los espermatozoides al óvulo de forma física. Estos son:

Preservativo masculino: también llamado condón, tiene forma de funda y se coloca en el pene. Su efectividad es del 97%.

Diafragma: es un capuchón de goma que se coloca en la vagina y obstruye el orificio del cuello del útero, evitando así el paso de los espermatozoides. Su efectividad es del 95%.

Dispositivo intrauterino (DIU): también conocido como T de cobre. El ginecólogo coloca el DIU en el interior del útero, tiene una efectividad del 95% y es de carácter permanente.

Anticonceptivos hormonales: son los más utilizados por la mujer, pueden estar compuestos por estrógenos que impiden la ovulación y progesterona.

Píldoras anticonceptivas: anticonceptivo en forma de pastillas que deben tomarse diariamente por vía oral.

Anticonceptivos inyectables: consisten en una inyección de hormonas por vía intramuscular. Su duración es de un mes o tres meses en función de la dosis hormonal y tiene una eficacia del 99%.

Implante anticonceptivo: consiste en un pequeño implante de plástico flexible que se coloca bajo la piel del brazo y va liberando la dosis hormonal necesaria para evitar la ovulación.

Control prenatal: control que se realiza desde la concepción hasta el nacimiento del bebé, etapas que no solamente son cruciales para el desarrollo del feto, sino también para la salud de la madre debido a los múltiples cambios físicos, hormonales y emocionales que presenta. (Centro médico ABC, 2025).

Deserción escolar: es un proceso de alejamiento sucesivo de la escuela que culmina con el abandono por parte del adolescente. (Universidad autónoma del Estado Hidalgo, SF).

Salud pública: La OMS y la OPS definen la salud pública como el conjunto de acciones organizadas por los gobiernos y la sociedad para prevenir enfermedades, proteger la salud de la población, prolongar la vida y promover el bienestar físico, mental y social. (OMS, s.f)

Prevención: es la acción de anticiparse a un riesgo, problema o daño para evitar que suceda. Implica tomar medidas, planificar y preparar recursos antes de algún evento negativo.

Educación integral en sexualidad (EIS): es un proceso curricular de enseñanza y aprendizaje sobre los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad. Su objetivo es dotar a los niños y jóvenes de conocimientos, capacidades, actitudes y valores que les permitan vivir con buena salud, bienestar y dignidad y desarrollar relaciones sociales y sexuales respetuosas. (UNESCO, 2026)

Proyecto de vida: puede definirse como un plan fundamental para la existencia. En su elaboración deben considerarse una serie de variables tales como necesidades u objetivos, que pueden coincidir o no con las expectativas que el entorno depositó sobre nosotros. Un proyecto de vida es una labor en construcción permanente que sigue cierta continuidad pero adaptada a la situación de cada momento. (Psicología y mente, 2026)

Capítulo III Marco Metodológico

El marco metodológico para Franco (2011) "consiste en el conjunto de acciones destinadas a describir y analizar el fondo del problema planteado, a través de procedimientos específicos que incluye las técnicas de observación y recolección de datos, determinando el "cómo" se realizará el estudio, esta tarea consiste en hacer operativa los conceptos y elementos del problema que estudiamos".

En función de lo antes expuesto en el presente capítulo se desarrollará el marco metodológico y los tipos de investigación que determinan el objetivo de los datos que vamos a recolectar para concretar nuestro proyecto y la operacionalización de variables. Para organizar bien la investigación, este se divide en cuatro partes clave: según su objeto, para ver si es básica (ampliar teoría) o aplicada (resolver problemas); según las fuentes, definiendo si es de campo (en el lugar de los hechos) o documental (revisando textos); según su enfoque, que determina si es cuantitativa (con números), cualitativa (analizando experiencias) o mixta; y según su alcance, que marca que tan profundo llega el análisis, ya sea exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. A continuación, se detallan los tipos específicos que se eligieron para este proyecto.

Tipos de investigaciones

Según su objeto:

La presente investigación según su objeto es aplicada ya que busca orientar a las mujeres sobre planificación familiar y uso correcto de métodos anticonceptivos para prevenir embarazos subsecuentes y disminuir la tasa de embarazos adolescentes que se presentan en el hospital Felipe Guevara Rojas.

Niño (2011) define la investigación aplicada como "Se ocupa de la resolución de problemas prácticos, dentro de la aplicación de la ciencia" (P. 38).

Según su fuente

Arias (2012) define la investigación de campo como "aquella que consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la información pero altera las condiciones existente (P. 31)

Esta investigación es de campo debido a que los datos que se encuentran en la presente investigación se recolectan de la realidad del Hospital Felipe Guevara Rojas y nuestros objetivos se enfocan en orientar a las personas que acuden a este centro de salud.

Según su enfoque

La presente investigación según su enfoque es mixta. Johson et al. (2006) es un "sentido amplio" visualizan la investigación mixta como un continuo en donde se mezclan los enfoques cuantitativo y cualitativo, centrándose más en uno de ellos o dándoles el mismo peso. (P. 566)

Es mixta debido a que se mezclan los enfoques cuantitativo y cualitativo. Ya que se analizan y se recolectan datos como las edades más afectadas, factores de riesgos, aumento de tasa de embarazo y barreras de uso de preservativos. Y además de eso tenemos comunicación con las personas afectadas para comprender su situación ofreciéndoles la orientación necesaria.

Según su alcance

Baptista Fernández et al 2014 define que la investigación explicativa pretende establecer las causas de los eventos, sucesos o fenómenos que se estudian (P. 126)

Según lo antes expuesto esta investigación es explicativa que estudiamos la situación actual del Hospital Felipe Guevara Rojas y nos enfocamos en identificar las causas de los embarazos en las adolescente (falta de educación sexual [] barreras para el uso de preservativos), para otorgarles educación sexual integral y diseñar una estrategia de consejería de enfermería en planificación familiar al momento del alta médica en el área de Sala de Partos del Hospital, orientada a superar las barreras de acceso identificadas y prevenir el embarazo subsecuente.

Objetivo General:

Diseñar una estrategia de consejería de enfermería en planificación familiar al momento del alta médica en el Área de Sala de Partos del Hospital "Dr. Felipe Guevara Rojas" de El Tigre, orientada a superar las barreras de acceso identificadas y prevenir el embarazo adolescente subsecuente.

Objetivos específicos	Variable	Dimensión	Indicadores	Instrumentos
Caracterizar el perfil sociodemográfico y obstétrico (edad, procedencia, nivel educativo, situación económica y paridad) de las adolescentes gestantes y puérperas ingresadas en el Hospital de El Tigre "Dr. Felipe Guevara Rojas".	Perfil Sociodemográfico y obstétrico de las adolescentes	Adolescentes • Gestantes • Puérperas	• Procedencia • Nivel educativo • Gestas • Paridad • Situación económica	• Cuestionario dirigido • Guía de observación
Identificar el nivel de conocimiento que poseen las adolescentes que asisten al Hospital "Dr. Felipe Guevara Rojas" sobre el mecanismo de acción, uso correcto y efectividad de los métodos anticonceptivos modernos.	Anticonceptivos modernos	Mecanismos de acción • Uso correcto • Efectividad • Datos sociodemográficos	• Sexo • Edad • Género • Grado de instrucción	• Cuestionario • Encuestas dirigidas

Determinar las barreras socioeconómicas e institucionales (costos en el mercado, escasez e insumos en el Hospital "Felipe Guevara Rojas" y transporte) que limitan el acceso de las adolescentes a los anticonceptivos.	Barreras de acceso a los anticonceptivos	• Barreras socioeconómicas • Barreras institucionales	• Costo • Disponibilidad • Escasez	• Cuestionario • Lista de cotejo
Proponer un catálogo de alternativas de intervención y contenidos educativos clave en planificación familiar, derivados de las barreras de acceso y el nivel de conocimiento identificados en las adolescentes.	Propuesta: Catálogo de intervención educativa	• Contenidos educativos clave • Estrategias de difusión	• Temas prioritarios • Formato del catálogo	• Guía de diseño • Matriz de propuesta

Población y muestra

Población

La población es un conjunto de individuos de la misma clase, limitada por el estudio. Según Tamayo y Tamayo (1997), La población se define como "la totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de la población poseen una característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación" (P. 114)

Según lo antes expuesto, llegamos a la conclusión de que La población en la cual se enfocará esta investigación está formada por los jóvenes de entre 12 y 19 años que asistan al servicio de ginecología Hospital "Dr. Felipe Guevara Rojas" en El Tigre, Estado Anzoátegui. Nos enfocamos en ellas porque representan el grupo que sufre directamente el problema del embarazo adolescente en la comunidad.

Muestra

Tamayo y Tamayo (2006), define la muestra como: "el conjunto de operaciones que se realizan para estudiar la distribución de determinados caracteres en totalidad de una población universo, o colectivo partiendo de la observación de una fracción de la población considerada (P. 176)

Continuando con lo antes definido, llegamos a la conclusión de que La muestra de esta investigación es de tipo intencional, lo que significa que se selecciona directamente a los participantes porque cumplen con las características específicas que se necesitan estudiar, debido al alto riesgo social y médico de sus casos. El grupo estará formado por todas las adolescentes de entre 12 y 19 años que asistan al servicio de ginecología del Hospital Dr. Felipe Guevara Rojas durante el tiempo de recolección de datos, siempre y cuando tengan su embarazo confirmado, estén en el rango de edad y acepten participar voluntariamente. Se selecciona este método porque al hospital siempre están llegando jóvenes con estas características y tenemos la necesidad de analizar a fondo su situación

Técnicas e instrumentos

Las técnicas de investigación comprenden el conjunto de procedimientos ordenados que permiten aprovechar los elementos del entorno donde ocurren los fenómenos estudiados. En este sentido, Hurtado (2010) señala que las técnicas se refieren específicamente a los

procesos operativos empleados para recopilar la información mientras que el instrumento constituye la herramienta física o digital utilizados para registrar, clasificar y codificar dichos datos (P. 74).

En función de lo antes expuesto se definen las técnicas utilizadas en esta investigación.

Encuesta

Segun Tamayo y Tamayo (2008; 24), la encuesta es aquella que permite dar respuestas a problemas de términos descriptivos como de relación de variables, tras la recogida sistemática de información segun un diseño previamente establecido que asegure el rigor de la información obtenida.

La implementación de una encuesta escrita mediante un cuestionario a las pacientes del Hospital General "Felipe Guevara Rojas, En El Tigre es indispensable porque, siguiendo el postulado metodológico de Tamayo y Tamayo (2008), esto servirá para recopilar información real y directa de las personas que estan viviendo el problema en El Tigre, permitiendo demostrar con números y datos exactos lo que esta pasando en ginecoobstetricia. Al hacerles preguntas a las pacientes, se conocen detalles clave como sus edades, si sabrían usar anticonceptivos, si recibieron educación sexual en el liceo (como exige la LOPNNA) o si dejaron de estudiar por el embarazo, lo que ayudará a conectar las causas del problema con las consecuencias que planteamos en esta investigación. Ademias, esta herramienta dará el respaldo científico que exige esta investigación, demostrando que nuestro análisis no se basa en opiniones, sino en la realidad comprobada de las adolescentes, lo que justifica porque es tan urgente aplicar algunas soluciones, como mejorar la atención médica confidencial en el hospital y llevar charlas educativas a las comunidades.

Entrevista

Segun Tamayo y Tamayo (2007) la entrevista es la relación directa establecida entre el investigador y su objetivo de estudio a traves de individuos o grupos con el fin de obtener testimonios orales, segun lo antes expuesto, la aplicación de la entrevista a las propias adolescentes embarazadas del Hospital Felipe Rojas servirá para establecer una relación directa con el sujeto de estudio y obtener testimonios orales profundos sobre su realidad, tal como lo plantea Tamayo y Tamayo (2007). Al escuchar sus propias voces, lograr comprender a fondo el lado humano, los miedos, las barreras emocionales y los motivos exactos por los

cuales acuden al centro de salud con muy poco o ningun control prenatal. Estos testimonios directos permitiran conocer, desde su perspectiva, las verdaderas razones por las que no pudieron acceder a método anticonceptivos en El Tigre, como vivieron la falta de educación sexual en sus liceos frente a lo que establece el artículo 50 de la LOPNNA, y de que manera esta situación interrumpe sus metas a futuro y sus proyectos de vida planteando por Erikson, aportando un análisis cualitativo que justifica la urgencia de reactivar consultas confidenciales y programas de educación sexual pensados especialmente para ellas.

Observación

Los autores Hernandez y Fernandez et al (2006:316) que: la observación directa consiste en el registro sistematico, valido y confiable de comportamiento o conducta manifiesta. A través de esta técnica el investigador puede obtener y recoger datos mediante su propia observación.

La aplicación de la observación directa en el Hospital Felipe Guevara Rojas servirá para ver con nuestros propios ojos y registrar en el tiempo real lo que ocurre directamente en el área de ginecoobstetricia, permitiendo comprobar el colapso del espacio y las largas horas de espera que pasan las jóvenes en El Tigre. Siguiendo a Hernandez y Fernandez, esta técnica ayudará a recolectar datos mediante una experiencia propia para verificar si las consultas realmente carecen de la privacidad y confidencialidad que las adolescente necesitan, evaluar como es el entorno de atención y verificar si en las salas de espera existe material educativo o informativo visual, dándole un respaldo real a la presente investigación al describir el problema tal y como sucede en el día a día.

Revisión documental

La investigación documental es una de las técnicas de la investigación cualitativa que se encarga de recolectar, recopilar y seleccionar información de las lecturas de documentos, revista, libros, grabaciones, filmaciones, periódicos, artículos resultados de investigaciones, memorias de eventos entre otros, en ella la observación está presente en el análisis de datos, su identificación y articulación con el objeto de estudio (Guerrero Dávila, 2015)

La revisión documental servirá para analizar leyes, estadísticas e informes oficiales que ya existen, dándole un respaldo legal y científico sólido a esta investigación en El Tigre. Siguiendo a Guerrero Dávila (2015), esta técnica ayudará a estudiar textos claves como el artículo 50 de la LOPNNA, los programas de educación sexual de la UNESCO y los reportes de la OMS o del propio Hospital Felipe Guevara Rojas; esto permitirá comparar las cifras locales con la realidad nacional, demostrar con bases legales que derechos se estén incumpliendo en los liceos y fundamentar las propuestas de solución con ejemplos de éxito documentados en otros centros de salud.

..ción de lo antes expuesto, se definen los instrumentos utilizados en esta investigación:

Instrumentos:

Según Tamayo y Tamayo (2011), "los instrumentos son formatos debidamente sistematizados, que permiten la recolección y categorización de los datos obtenidos de las fuentes primarias". Al respecto, Sabino (2010) indica que un instrumento de recolección de datos en principio, es cualquier recurso del que pueda valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. (p.74)

Cuestionario

El autor Tamayo y Tamayo (2008, p. 124) señala que "el cuestionario contiene los aspectos del fenómeno que se consideran esenciales; permite, además, aislar ciertos problemas que nos interesan principalmente; reduce la realidad a cierto número de datos esenciales y precisa el objeto de estudio.

Siguiendo esta definición se concluye que el uso del cuestionario en esta investigación es fundamental porque se necesita medir el nivel de conocimiento sobre sexualidad y anticoncepción en una gran cantidad de estudiantes de los liceos de El Tigre en poco tiempo. Su carácter anónimo facilita obtener respuestas sinceras sobre un tema sensible. Este instrumento aporta un valor central al trabajo, ya que permite lograr diagnosticar con cifras el rezago educativo mencionado, identificar qué planteles presentan mayor déficit de información y justificar la urgencia de implementar los programas de la UNESCO en cada institución.

Un ejemplo sencillo de cuestionario sería: "¿Sabes en que fase del ciclo menstrual es más fácil quedar embarazada? a) Durante la regla, b) A mitad del ciclo (ovulación), c) Al final. Si el 80% falla, se demuestra cuantitativamente el rezago.

Guía de entrevista

Según Hurtado (2006, p. 161), la guía de entrevista es un instrumento propio de la técnica de entrevista en el cual se señalan los temas o aspectos en torno a los cuales se va a preguntar. Dependiendo del grado de estructuración, puede contener preguntas ya formuladas o solo enunciados temáticos.

Se aplica en esta investigación porque los datos numéricos no explican por sí solos las barreras emocionales, el estigma o el trato deficiente que pueden estar alejando a las adolescentes del control prenatal. Se necesita indagar a fondo en la experiencia vivida, aspecto que les facilita la entrevista. Además, sirve para detectar fallas no visibilizadas en la confidencialidad y la atención del personal del Hospital "Dr. Felipe Guevara Rojas", permitiendo proponer una reestructuración del servicio con un enfoque humano y libre de juicios.

Guía de Observación

Según Tamayo (2004, p. 172), la guía de observación se define como un formato en el cual se pueden recolectar los datos de manera sistemática y registrarlos en forma uniforme, su utilidad consiste en ofrecer una revisión clara y objetiva de los hechos, agrupar los datos

según necesidades específicas y responder a la estructura de las variables o elementos del problema.

La guía de observación directa en el Hospital "Dr. Felipe Guevara Rojas" es una herramienta clave porque permite registrar hechos reales y objetivos en el sitio, contrastando las versiones oficiales con las dinámicas diarias en la sala de espera. Este instrumento sirve para evaluar tres ejes críticos: la accesibilidad del servicio (horarios y señalización), la calidad del trato (privacidad y estigmatización) y el flujo asistencial de las adolescentes a sus controles prenatales. Para lograrlo la guía se estructura en cinco categorías esenciales que analizan la infraestructura, el flujo de pacientes, la interacción entre el personal y la usuaria, la revisión de historias clínicas y la disponibilidad real de anticonceptivos; lo que permite concluir con datos concretos si la atención tiene las consultas o si el espacio físico está colapsado, validando así el pronóstico de vulnerabilidad en el derecho a la salud sexual y reproductiva de la localidad.

Matriz de Registro

Según Hurtado (2008, p. 159), la matriz de registro como instrumento de recolección de datos de la técnica de revisión documental "se utiliza para asentar datos obtenidos a través de la medición con otros instrumentos, datos obtenidos de archivos o registros institucionales."

La matriz de registro como instrumento de revisión documental, basada en el postulado de Hurtado (2008), es fundamental en esta investigación porque permite recolectar y organizar datos objetivos de archivos e informes institucionales, dándole un sustento estadístico e histórico al pronóstico que complementa la observación directa. Este instrumento sirve para cuantificar las atenciones a adolescentes en el Hospital "Dr. Felipe Guevara Rojas", verificar el cumplimiento real de la LOPNNA y las directrices de la UNESCO en los liceos, y detectar las brechas existentes entre lo establecido en la ley y lo que reflejan los registros. De este modo, la matriz ayuda a demostrar con evidencias claras que la falta de control prenatal, las altas tasas de fecundidad local y la ausencia de programas educativos responder a una falla estructural en los sistemas de salud y educación de El Tigre.

Entrevista

1. ¿Cuántos años tienes, cuál es tu último nivel de estudio y cuántos embarazos has tenido?
2. ¿Qué sabías antes, sobre el uso y la efectividad de los métodos anticonceptivos modernos?
3. ¿Qué dificultades has tenido para conseguir anticonceptivos (dinero, transporte o falta de insumos en el hospital)?
4. ¿Qué tema sobre sexualidad y planificación familiar, crees que necesitan aprender más las jóvenes de tu edad?
5. ¿De qué manera te gustaría recibir información y ayuda sobre estos temas por parte del hospital?

Encuesta (dicotómicas)

1. ¿Eres menor de 18 años? Sí, no

2. ¿Has logrado terminar el bachillerato?
3. ¿Estás estudiando actualmente?
4. ¿Es tu primer embarazo?
5. ¿Conoces el uso correcto de anticonceptivos modernos?
6. ¿Sabes como funciona el implante subdérmico o el DIU?
7. ¿Has dejado de usar anticonceptivos por falta de dinero?
8. ¿Has intentado buscar anticonceptivos en el hospital y te han dicho que no hay?
9. ¿Sientes que necesitas más información sobre planificación familiar?
10. ¿Estarías dispuesta a que te coloquen un método anticonceptivo gratuito antes de salir del hospital?

Validez y Confiabilidad

De acuerdo con Hernandez, Fernandez et. al (1998) "La validez en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir". (Pág. 243). En la presente investigación se aplicará la validez de contenido que según

Escobar (2008) citando a Ding y Hershberger (2002), la validez de contenido es un componente importante de la estimación de la validez de inferencias derivadas de los puntajes de las pruebas, ya que brinda evidencia acerca de la validez de constructo y provee una base para la construcción de formas paralelas de una prueba en la evaluación a gran escala

Dicha validez será realizada por (03) tres expertos en el área de salud pública y obstetricia, y especialistas en educación sexual integral, todos con conocimiento de la realidad sociosanitaria del municipio Simón Rodríguez con el fin de determinar si los ítems del cuestionario realmente miden las variables clave de esta investigación, el nivel de conocimiento sobre salud reproductiva en las adolescentes, la percepción sobre la accesibilidad a métodos anticonceptivos en la red local, y las barreras que enfrentan para acudir el control prenatal en el Hospital "Dr. Felipe Guevara Rojas" asegurando que el instrumento refleje finalmente las fallas en las atención diferenciada y el rezago educativo denunciados en la comunidad.

Confiabilidad

Ruiz () Citando a Hernandez et.al (2003:243), indican que la confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados.

Si bien la confiabilidad del presente instrumento aplicado a esta investigación, se trata de un instrumento de recolección de datos constituido en una encuesta de 10 preguntas de opción dicotómica (si/no) que su propósito principal es obtener datos rápidos y precisos sobre la situación de las adolescentes, para calcular la confiabilidad el método a utilizar es el coeficiente Kuder-Richardson 20 (KR-20). Según (Richardson 1937) menciona que es una medida estadística de consistencia interna que evalúa la confiabilidad de un instrumento de medición con respuestas dicotómicas.

